GLAXOSMITHKLINE PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis, inactivated polio and *Haemophilus influenzae* type b vaccine
Vắc xin kết hợp bạch hầu-uốn ván-ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt và *Haemophilus influenzae* tuýp b

Infanrix IPV Hib

©2016 GSK group of companies or its licensor
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut, 89
B-1330 Rixensart, Belgium

DFT-00338-2415343

Keep out of the sight and reach of children
Read the package leaflet before use.
Medicinal product subject to medical prescription.
Shake before use. Protect from light. Do not freeze.
Storage:+2°C/+8°C
For intramuscular injection.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xin xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Bảo quản: +2 đến +8°C. Không để đông đá. Tránh ánh sáng.
Số lô SX, NSX, HD: xem "LOT", "MFD", "EXP" trên bao bì.
Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn in trên bao bì.

Sản xuất bởi:
GlaxoSmithKline Biologicals
637 rue des Aulnois, 59230 Saint Amand Les Eaux, France/Pháp

Xuất xưởng bởi:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A
89 Rue de l'Institut, 1330 Rixensart, Belgium/Bỉ
Tiêu chuẩn: TCCS

DNNK

LOT/MFD/EXP:

PHARMA CODE N°

1 reconstituted dose contains/ 1 liều sau hoàn nguyên chứa:

Diphtheria toxoid/ Giải độc tố bạch hầu	min 30 I.U.
Tetanus toxoid/ Giải độc tố uốn ván	min 40 I.U.
Pertussis toxoid (PT)/ Giải độc tố ho gà	25mcg
Filamentous Haemagglutinin (FHA)/ Ngưng kết hồng cầu dạng sợi	25mcg
Pertactin (69 kDa OMP)/ Pertactin	8mcg
Inactivated Polio Virus Type I/ Virus bại liệt bất hoạt tuýp 1	40 DU
Inactivated Polio Virus Type II/ Virus bại liệt bất hoạt tuýp 2	8 DU
Inactivated Polio Virus Type III/ Virus bại liệt bất hoạt tuýp 3	32 DU
Haemophilus influenzae type b polysaccharide conjugated to tetanus toxoid/ Polysaccharide *Haemophilus influenzae* tuýp b cộng hợp với protein chuyển chở là giải độc tố uốn ván	10 mcg

The lyophilised powder (Hib) must be reconstituted with DTPa-IPV suspension
Bột đông khô (Hib) phải được hoàn nguyên cùng hỗn dịch DTPa-IPV

55x24x133 A14

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 19/2/2019

1 dose/ 1 liều (0.5 ml)

DTPa-IPV in prefilled syringe + 2 needles
+ lyophilised Hib in vial

Hộp chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa hỗn dịch DTPa-IPV, 1 lọ vắc xin Hib đông khô và 2 kim tiêm.

Tiêm bắp

Reg./SĐK:

Combined diphtheria-tetanus-acellular pertussis, inactivated polio and *Haemophilus influenzae* type b vaccine

Vaccin combiné contre la diphtérie (D), le tétanos (T), la coqueluche (acellulaire) (Ca), le virus inactivé de la poliomyélite (VPI) et l'*Haemophilus influenzae* de type b (Hib)

Vacuna combinada contra la difteria-tétanus-pertussis acelular, poliomielitis inactivada y *Haemophilus influenzae* tipo b

Rx Thuốc kê đơn

Infanrix IPV Hib

Powder and suspension for suspension for injection
Poudre et suspension pour suspension injectable

Polvo y suspensión para suspensión inyectable

Infanrix IPV Hib

PHARMA CODE N°

QĐ 72/QĐ-QLD

To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing:
FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 7 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 7).
Overprint Preview must be activated for accurate on screen viewing.
FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 7 or higher. **"Apply Overprint Preview"** or **"Simulate Overprinting"** must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.

180 mm Measuring Bar

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

IMPORTANT

GSK Market is responsible for this product, its design and content.
Ensure the artwork is thoroughly checked, all the text proof-read and approved.

RSC GSK is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise RSC in case changes required impact the followings:

Formulation
Tablet embossing
Storage conditions
Shelf Life

Vaccines Additional Information Panel
Removable parts n.: 1
2D Pharmacode value: N/A

TEXT SIZE CONTAINED IN THIS ARTWORK
Body text size: 4.0pt
Smallest text size: 4.0pt
Microtext: No



ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION • ATTENTION

To Ensure Accurate PDF Viewing and Printing:
FOR SCREEN VIEWING: Use Adobe Acrobat 7 Professional or Adobe Acrobat Reader, Standard or Professional (higher than 7).
Overprint Preview must be activated for accurate on screen viewing.
FOR PRINTING: Use only Acrobat Professional version 7 or higher. **"Apply Overprint Preview"** or **"Simulate Overprinting"** must be activated in the print settings for printing accurate hard copies.

180 mm Measuring Bar

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

IMPORTANT

GSK Market is responsible for this product, its design and content.
Ensure the artwork is thoroughly checked, all the text proof-read and approved.

RSC GSK is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise RSC in case changes required impact the followings:

Formulation
Tablet embossing
Storage conditions
Shelf Life

Vaccines Additional Information Panel
Removable parts n.: N/A
2D Pharmacode value: N/A

TEXT SIZE CONTAINED IN THIS ARTWORK
Body text size: 4.0pt
Smallest text size: 4.0pt
Microtext: No

GLAXOSMITHKLINE PTE
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC

INFANRIX-IPV+HIB

Vắc-xin kết hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt và *Haemophilus influenzae* týp b

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ.

1. Tên sản phẩm

Infanrix-IPV+Hib

Vắc-xin kết hợp bạch hầu-uốn ván-ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt và *Haemophilus influenzae* tuýp b.

2. Thành phần định tính và định lượng

Sau hoàn nguyên, 1 liều (0,5 ml) có chứa:

Giải độc tố bạch hầu[1]	không ít hơn 30 Đơn vị Quốc tế (IU) (25 Lf)
Giải độc tố uốn ván[1]	không ít hơn 40 Đơn vị Quốc tế (IU) (10 Lf)
Kháng nguyên *Bordetella pertussis*	
Giải độc tố ho gà (PT)[1]	25 microgram
Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA)[1]	25 microgram
Pertactin (PRN)[1]	8 microgram
Virus bại liệt (bất hoạt) (IPV)	
tuýp 1 (chủng Mahoney)[2]	40 đơn vị kháng nguyên D
tuýp 2 (chủng MEF-1)[2]	8 đơn vị kháng nguyên D
tuýp 3 (chủng Saukett)[2]	32 đơn vị kháng nguyên D
Polysaccharide *Haemophilus influenzae* týp b (polyribosylribitol phosphate) (PRP) cộng hợp với protein chuyên chở là giải độc tố uốn ván	10 microgram xấp xỉ 25 microgram
[1] được hấp phụ trên aluminium hydroxide, hydrate hoá ($Al(OH)_3$)	0,5 milligram Al^{3+}

[2] được nhân lên trên dòng tế bào VERO

Thành phần Infanrix-IPV là một hỗn dịch màu trắng đục. Trong quá trình bảo quản, có thể quan sát thấy tủa trắng và phần nước nổi trong. Thành phần Hib của vắc xin là bột màu trắng.

3. Dạng bào chế

Bột đông khô (Hib) và hỗn dịch (DTPa- IPV) để pha hỗn dịch tiêm.

4. Đặc tính lâm sàng

4.1. Chỉ định

Infanrix-IPV+Hib được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động cho trẻ từ 2 tháng tuổi phòng ngừa bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà (DTP), bại liệt và *Haemophilus influenzae* týp b.

Infanrix-IPV+Hib còn được chỉ định để tiêm nhắc lại cho trẻ đã được tiêm chủng phòng ngừa bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà (DTP), bại liệt và *Haemophilus influenzae* týp b.

Infanrix-IPV+Hib không bảo vệ được các bệnh gây ra bởi các týp *Haemophilus influenzae* khác cũng như viêm màng não gây ra bởi các vi sinh vật khác.

4.2. Liều lượng và cách dùng

Liều lượng

- Lịch tiêm chủng cơ bản gồm 3 mũi trong 6 tháng đầu đời và có thể bắt đầu từ 2 tháng tuổi. Khoảng cách giữa các mũi tiêm cách nhau ít nhất 1 tháng.
- Một liều tiêm nhắc được khuyến cáo vào năm tuổi thứ 2 và cách mũi tiêm cuối cùng trong lịch chủng ngừa cơ bản ít nhất là 6 tháng

Cách dùng

Infanrix-IPV+Hib được dùng qua đường tiêm bắp **sâu** ở phần trước bên của đùi. Các mũi tiêm tiếp theo nên được thay đổi vị trí tiêm ở hai đùi luân phiên.

Nên thận trọng khi tiêm ***Infanrix-IPV+Hib*** cho những đối tượng bị giảm tiểu cầu hoặc rối loạn chảy máu vì có thể xảy ra hiện tượng chảy máu sau khi tiêm bắp cho những đối tượng này. Nên đè chặt vị trí tiêm (không chà xát) ít nhất trong 2 phút.

4.3. Chống chỉ định

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin hoặc các đối tượng có dấu hiệu quá mẫn sau mũi tiêm vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt bất hoạt hoặc Hib trước đó.

Chống chỉ định dùng ***Infanrix-IPV+Hib*** nếu trẻ có biểu hiện bệnh não không rõ nguyên nhân trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng vắc-xin có chứa thành phần ho gà trước đó.

4.4. Cảnh báo và thận trọng đặc biệt

Nên hỏi tiền sử y khoa trước khi tiêm chủng (nhất là việc tiêm chủng trước đó và các biến cố ngoại ý có khả năng xảy ra) và khám lâm sàng.

Giống như các vắc-xin khác, nên hoãn tiêm ***Infanrix-IPV+Hib*** cho các đối tượng đang sốt cao cấp tính. Không chống chỉ định khi có biểu hiện nhiễm khuẩn nhẹ.

Nên thận trọng khi tiêm ***Infanrix-IPV+Hib*** cho những đối tượng bị giảm tiểu cầu hoặc rối loạn máu chảy vì có thể xảy ra hiện tượng chảy máu sau khi tiêm bắp cho những đối tượng này.

Cũng như tất cả các vắc-xin dạng tiêm, cần luôn có sẵn các biện pháp điều trị y tế và theo dõi thích hợp đề phòng phản ứng phản vệ hiếm gặp có thể xảy ra sau tiêm chủng.

Người được tiêm chủng có thể bị ngất xỉu sau hoặc thậm chí trước khi tiêm. Đây là một phản ứng tâm lý đối với mũi tiêm. Điều quan trọng là nên có sẵn quy trình để phòng tránh bị thương do ngất xỉu.

Không khuyến cáo sử dụng ***Infanrix-IPV+Hib*** cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Cũng như tất cả các vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván khác, ***Infanrix-IPV+Hib*** được dùng qua đường tiêm bắp sâu ở phần trước bên của bắp đùi. Các mũi tiêm tiếp theo nên được thay đổi vị trí tiêm ở hai đùi luân phiên.

Có thể không đạt được đáp ứng miễn dịch như mong đợi sau khi tiêm chủng cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, ví dụ những bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch.

Nếu bất kỳ biểu hiện nào dưới đây xảy ra trong khoảng thời gian tiêm chủng với vắc xin có thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván, cần thận trọng khi quyết định sử dụng tiếp vắc xin có chứa thành phần ho gà. Những biểu hiện bao gồm:

- Nhiệt độ ≥ 40,0°C (đo ở hậu môn) trong vòng 48 giờ mà không phát hiện nguyên nhân nào khác;
- Trụy mạch hoặc tình trạng giống shock (cơn giảm trương lực cơ - giảm đáp ứng) trong vòng 48 giờ sau tiêm chủng;
- Quấy khóc kéo dài dỗ không nín ≥ 3 giờ, xuất hiện trong vòng 48 giờ sau tiêm chủng;
- Co giật kèm hoặc không kèm theo sốt, xuất hiện trong vòng 3 ngày sau tiêm chủng.

Tuy nhiên, do những biến cố trên không liên quan đến các biến chứng lâu dài, có những trường hợp, ví dụ khi tần suất mắc ho gà cao thì lợi ích tiềm tàng sẽ lớn hơn các nguy cơ có thể xảy ra.

Ở những trẻ có các rối loạn thần kinh tiến triển, bao gồm các chứng co thắt ở trẻ nhũ nhi, động kinh không kiểm soát hoặc bệnh não tiến triển, tốt hơn nên hoãn tiêm vắc-xin ho gà (vô bào hoặc toàn tế bào) cho đến khi bệnh khỏi hoặc ổn định. Tuy nhiên, quyết định có tiêm phòng hay không phải tùy thuộc từng trường hợp cụ thể sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về nguy cơ và lợi ích của việc tiêm phòng.

Không chống chỉ định dùng ***Infanrix-IPV+Hib*** khi trẻ có tiền sử sốt co giật, tiền sử gia đình về co giật hay hội chứng tử vong đột ngột ở nhũ nhi (SIDS), tiền sử gia đình có biến cố bất lợi khi chủng ngừa với DTP, IPV và/hoặc Hib

Nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) không được xem là chống chỉ định.

Kháng nguyên vỏ polysaccharide Hib được bài tiết vào nước tiểu sau khi tiêm vắc xin, vì vậy trong vòng 1-2 tuần sau khi tiêm vắc xin, xét nghiệm phát hiện kháng nguyên trong nước tiểu có thể không có giá trị chẩn đoán trong trường hợp nghi ngờ trẻ mắc bệnh do Hib.

Không tiêm ***Infanrix-IPV+Hib*** vào tĩnh mạch trong bất kể trường hợp nào.

Khi thực hiện chủng ngừa cơ bản cho trẻ sinh cực non (sinh ≤ 28 tuần tuổi thai) đặc biệt ở những trẻ sinh non có tiền sử chưa trưởng thành phổi, có nguy cơ tiềm tàng gây ngưng thở và cần theo dõi hô hấp trong vòng 48-72 giờ sau khi tiêm vắc-xin. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin ở các đối tượng này là cao, vì vậy không nên trì hoãn hay từ chối việc tiêm phòng.

4.5. Tương tác

Theo thực hành tiêm chủng trẻ em hiện nay về việc có thể tiêm các vắc xin khác nhau trong cùng một buổi tiêm, ***Infanrix-IPV+Hib*** có thể tiêm cùng với vắc xin viêm gan B.

Nên tiêm vắc xin ***Infanrix-IPV+Hib*** đã hoàn nguyên và vắc xin tiêm khác ở những vị trí tiêm khác nhau.

Cũng như các vắc xin khác, có thể không đạt được đáp ứng miễn dịch như mong đợi ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch.

4.6. Thai kỳ và cho con bú

Do ***Infanrix-IPV+Hib*** không được sử dụng cho người lớn nên không có thông tin về an toàn khi sử dụng vắc xin trong thai kỳ hoặc cho con bú.

4.7. Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không áp dụng.

4.8. Tác dụng không mong muốn

- ***Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng***

Đặc tính an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu từ hơn 3500 trẻ.

Như đã quan sát thấy với vắc xin DTPa và vắc xin kết hợp chứa DTPa, đã có báo cáo về việc tăng tính sinh phản ứng tại chỗ và sốt sau khi tiêm nhắc lại bằng ***Infanrix-IPV+Hib*** so với tiêm chủng cơ bản.

Tác dụng không mong muốn được báo cáo được phân loại theo tần suất như sau:

Rất phổ biến: ≥ 1/10

Phổ biến: ≥ 1/100 đến <1/10

Không phổ biến: ≥ 1/1000 đến < 1/100

Hiếm: ≥ 1/10000 đến < 1/1000

Rất hiếm: <1/10000

Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng

Không phổ biến: nhiễm khuẩn đường hô hấp trên

Rối loạn máu và hệ bạch huyết:

Không phổ biến sưng hạch bạch huyết

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Rất phổ biến: chán ăn

Rối loạn tâm thần

Rất phổ biến: kích thích, quấy khóc bất thường, bứt rứt

Rối loạn thần kinh

Rất phổ biến: ngủ gà

Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất

Không phổ biến: ho, viêm phế quản, chảy nước mũi.

Rối loạn tiêu hóa

Phổ biến: nôn, tiêu chảy

Rối loạn da và mô dưới da

Không phổ biến: phát ban, mề đay

Hiếm: ngứa, viêm da

Rối loạn toàn thân và tại chỗ tiêm

Rất phổ biến: phản ứng tại chỗ tiêm như đau, đỏ, sưng tại chỗ tiêm (≤ 50mm), sốt (≥ 38°C)

Phổ biến: phản ứng tại chỗ tiêm bao gồm nề cứng, sưng tại chỗ tiêm (> 50mm)[1],

Không phổ biến: sốt[2] > 39,5°C, mệt mỏi, sưng lan tỏa chi được tiêm, đôi khi lan đến khớp gần kề[1]

- ***Dữ liệu hậu mãi***

Rối loạn máu và hệ bạch huyết

Giảm tiểu cầu[4].

Rối loạn hệ miễn dịch

Phản ứng dị ứng (bao gồm phản ứng phản vệ[3] và phản ứng dạng phản vệ)

Rối loạn hệ thần kinh

Co giật (sốt hoặc không sốt), trụy mạch hoặc tình trạng giống shock (cơn giảm trương lực cơ - giảm đáp ứng)

Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất

Ngưng thở[3] [Xem mục *Cảnh báo và Thận trọng* về nguy cơ ngưng thở ở trẻ sinh cực non (sinh ≤ 28 tuần tuổi thai)]

Rối loạn da và mô dưới da

Phù mạch thần kinh[3]

Rối loạn toàn thân và tại chỗ tiêm

Sưng toàn bộ chi được tiêm vắc xin[1], mụn nước tại chỗ tiêm[3]

[1]Trẻ được tiêm chủng cơ bản bằng vắc xin ho gà vô bào có khả năng bị phản ứng sưng sau mũi nhắc lại nhiều hơn so với trẻ tiêm chủng cơ bản bằng vắc-xin ho gà toàn tế bào. Phản ứng này thường chấm dứt sau khoảng 4 ngày.

[2]Phổ biến với mũi tiêm nhắc lại

[3]Được báo cáo với các vắc-xin khác chứa DTPa của GSK.

[4]Được báo cáo với các vắc-xin uốn ván và bạch hầu.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

4.9. Quá liều

Một số trường hợp quá liều đã được báo cáo trong suốt quá trình giám sát hậu mãi. Các tác dụng phụ báo cáo sau khi dùng quá liều cũng tương tự như những tác dụng phụ quan sát được sau khi dùng liều khuyến cáo của ***Infanrix-IPV+Hib***.

5. Các đặc tính dược học

5.1. Dược lực học

Nhóm dược lý – điều trị: Nhóm vắc-xin vi khuẩn và virus kết hợp, mã ATC: J07CA06. Kết quả thu được trong các nghiên cứu lâm sàng từ mỗi thành phần được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Tỷ lệ phần trăm trẻ có hiệu giá kháng thể ≥ giá trị ngưỡng sau tiêm chủng cơ bản bằng *Infanrix-IPV+Hib*

Kháng thể (ngưỡng)	3-5 tháng tuổi N= 86 (1 nghiên cứu) %	1,5-3,5-6 tháng tuổi N= 62 (1 nghiên cứu) %	2-3-4 tháng tuổi N= 337 (3 nghiên cứu) %	2-4-6 tháng tuổi N= 624 (6 nghiên cứu) %	3-4-5 tháng tuổi N= 127 (2 nghiên cứu) %	3-4,5-6 tháng tuổi N=198 (1 nghiên cứu) %
Kháng bạch hầu (0,1 IU/ml) *	94,1	100	98,8	99,3	94,4	99,5
Kháng uốn ván (0,1 IU/ml) *	100,0**	100	99,7	99,8	99,2	100
Kháng PT (5 EL.U/ml)	99,5**	100	99,4	100	98,4	100
Kháng FHA (5 EL.U/ml)	99,7**	100	100	100	100	100
Kháng PRN (5 EL.U/ml)	99,0**	100	100	100	100	100
Kháng bại liệt tuýp 1 (pha loãng 1/8) *	93,0	ND	99,1	99,5	100	100
Kháng bại liệt tuýp 2 (pha loãng 1/8) *	95,3	ND	95,7	99,0	99,2	100
Kháng bại liệt tuýp 3 (pha loãng 1/8) *	98,8	ND	100	100	99,2	99,4
Kháng PRP (Hib) (0,15 mcg/ml) *	83,7	100	98,5	98,5	100	98,4
Kháng-PRP (Hib) (1,0 µg/ml)	51,2	87,1	68,5	76,0	97,6	81,2

N: Số đối tượng nghiên cứu

ND: không xác định

*: ngưỡng được xem là có tác dụng bảo vệ

**: Kết quả sau 2 liều tiêm từ những nghiên cứu trên các đối tượng tiêm vắc-xin DTPa-HBV-IPV+Hib theo lịch 3, 5 và 11 tháng tuổi

Tỷ lệ phần trăm trẻ có hiệu giá kháng thể ≥ giá trị ngưỡng sau tiêm nhắc lại bằng *Infanrix-IPV+Hib*

Kháng thể (ngưỡng)	**Tiêm nhắc lại vào 11/12 tháng tuổi sau khi tiêm chủng cơ bản lúc 3-5 tháng tuổi N= 184 (1 nghiên cứu) %**	**Tiêm nhắc lại trong năm tuổi thứ 2 sau khi tiêm chủng cơ bản 3 mũi N= 1326 (9 nghiên cứu) %**
Kháng bạch hầu (0,1 IU/ml) *	100	99,8
Kháng uốn ván (0,1 IU/ml) *	99,9**	99,9
Kháng PT (5 EL.U/ml)	99,9**	99,7
Kháng FHA (5 EL.U/ml)	99,9**	100
Kháng PRN (5 EL.U/ml)	99,5**	99,9
Kháng bại liệt tuýp 1 (pha loãng 1/8) *	99,4	99,9
Kháng bại liệt tuýp 2 (pha loãng 1/8) *	100	100
Kháng bại liệt tuýp 3 (pha loãng 1/8) *	99,4	100
Kháng PRP (0,15 mcg/ml) *	100	100
Kháng PRP (1,0 mcg/ml)	96,7	99,2

N = số đối tượng nghiên cứu

* Ngưỡng được xem là có tác dụng bảo vệ

**: Kết quả sau 3 liều tiêm từ các nghiên cứu trên các đối tượng tiêm vắc-xin DTPa-HBV-IPV+Hib theo lịch 3, 5 và 11 tháng tuổi.

Hiệu quả của thành phần Hib (khi kết hợp với DTPa, DTPa-IPV, hoặc DTPa-HBV-IPV) được khảo sát thông qua một nghiên cứu giám sát hậu mãi quy mô lớn được tiến hành tại Đức. Sau hơn 4,5 năm theo dõi, hiệu quả của vắc xin DTPa+Hib hoặc DTPa-IPV+Hib, là 96,7% sau loạt tiêm chủng cơ bản và 98,5% sau loạt tiêm nhắc lại (bất kể loại vắc xin nào đã được sử dụng trong tiêm chủng cơ bản). Sau hơn 7 năm theo dõi, hiệu quả của thành phần Hib của 2 vắc xin 6 giá trị là 89,6% sau loạt tiêm chủng cơ bản và 100% sau loạt tiêm chủng cơ bản và liều nhắc (bất kể loại vắc-xin Hib nào đã được sử dụng trong tiêm chủng cơ bản).

5.2. Dược động học

Không yêu cầu đánh giá đặc tính dược động học đối với vắc-xin.

5.3. Các nghiên cứu lâm sàng

Xem phần "*Dược lực học*".

5.4. Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dữ liệu tiền lâm sàng không cho thấy bất lợi đặc biệt cho người dựa trên các nghiên cứu quy ước về an toàn dược lý, dung nạp tại chỗ và độc tính liều nhắc lại.

6. Các đặc tính dược học

6.1. Danh sách tá dược

Lactose, sodium chloride (NaCl), Medium 199, nước pha tiêm.

Potassium chloride, disodium phosphate, monopotassium phosphate, polysorbate 80, glycine, formaldehyde, neomycin sulphate, polymyxin sulphate là những chất tồn dư từ quá trình sản xuất.

6.2. Tương kỵ

Không trộn ***Infanrix-IPV+Hib*** với vắc xin khác trong cùng bơm tiêm.

6.3. Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Hạn dùng của vắc xin được ghi trên nhãn và vỏ hộp.

6.4. Thận trọng đặc biệt khi bảo quản

Các thành phần ***Infanrix-IPV và Hib*** nên được bảo quản ở +2°C đến +8°C.

Không để đông đá thành phần ***Infanrix-IPV***. Loại bỏ nếu thành phần này bị đông đá.

Tránh ánh sáng.

Nên tuân thủ khuyến cáo về điều kiện bảo quản vắc xin trong quá trình vận chuyển.

6.5. Quy cách đóng gói

Thành phần Infanrix-IPV được đóng sẵn trong bơm tiêm. Thành phần Hib được đóng trong lọ thủy tinh.

Lọ và bơm tiêm đóng sẵn được làm từ thủy tinh trung tính loại I, tuân theo các tiêu chuẩn của Dược điển Châu Âu.

Hộp chứa 1 bơm tiêm (Infanrix-IPV), 2 kim tiêm và 1 lọ bột đông khô (Hib).

6.6. Hướng dẫn sử dụng/xử lý

Trước khi sử dụng, nên kiểm tra bằng mắt xem hỗn dịch Infanrix - IPV và bột Hib và vắc xin sau hoàn nguyên xem có phần tử lạ và/hoặc bất kỳ thay đổi vật lý nào hay không. Loại bỏ vắc xin nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Vì vắc xin có thể lắng cặn màu trắng trong quá trình bảo quản, nên lắc kỹ hỗn dịch Infanrix - IPV trước khi hoàn nguyên.

Vắc xin phải được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ phần Infanrix - IPV trong bơm tiêm vào lọ chứa bột Hib. Chỉ những thành phần của vắc xin mới được trộn vào nhau mà không trộn lẫn với các vắc xin khác hoặc các thành phần thuộc lô khác. Sau khi trộn hỗn dịch Infanrix -IPV vào bột Hib, hỗn hợp nên được lắc kỹ.

Vắc xin ***Infanrix-IPV+Hib*** sau khi hoàn nguyên là hỗn dịch có màu hơi đục hơn so với hỗn dịch DTPa- IPV ban đầu. Đây là một hiện tượng quan sát bình thường. Loại bỏ vắc xin nếu quan sát thấy bất thường.

Khi tiêm vắc xin, cần tháo và bỏ kim tiêm thứ nhất và thay thế bằng kim tiêm thứ hai.

Nên tiêm vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên.

Rút hết phần vắc xin trong lọ.

Nên hủy bỏ sản phẩm không được sử dụng hoặc vật liệu không dùng theo quy định.

Sản xuất bởi

GlaxoSmithKline Biologicals.

637 rue des Aulnois,

59230 Saint Amand Les Eaux, France/Pháp

Chịu trách nhiệm xuất xưởng:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A

89 rue de l'Institut

1330 Rixensart, Belgium/Bỉ

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

Nhãn hiệu sở hữu bởi hoặc cấp phép cho tập đoàn GSK

Dựa trên phiên bản GDS012/IPI 08 ban hành ngày 29/09/2016

INFI 0418-08/290916

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

KT.Q. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng